## AIR Resident and PGY 工作守則

**##Primary Care##**

1. 本科醫師陣容：(建議可記住自己跟的 VS 門診時間，以利與家屬討論出院返診時間！)
   ✔ 主治醫師：
   黃璟隆院長(0254)、陳力振主任(2226)、林思偕醫師(2462)、葉國偉醫師(2285)、李文益醫師(2707)、歐良修醫師(3115)、姚宗杰醫師(3537)、吳昭儀醫師(0333)、蘇冠文主任(4220)、高純淳醫師(0659)。

| 時間/星期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上午 | 李文益<br>林思偕<br>葉國偉<br>黃璟隆<br>蘇冠文(基) | 歐良修<br>李欣儒<br>林思偕(桃) | 姚宗杰<br>李文益<br>吳昭儀<br>蘇冠文(基) | 蘇冠文(北) | 姚宗杰<br>歐良修<br>葉國偉<br>吳昭儀 | 李文益<br>林思偕<br>吳昭儀<br>蘇冠文(基) |
| 下午 | 姚宗杰<br>李文益 | 吳昭儀<br>蘇冠文(基) | 歐良修<br>林思偕<br>葉國偉<br>陳力振<br>李文益(北) | 高純淳<br>吳昭儀<br>葉國偉(土)<br>蘇冠文(基) | 蘇冠文<br>姚宗杰<br>林思偕<br>李文益(北)<br>歐良修(桃) | 李文益<br>林思偕<br>吳昭儀<br>蘇冠文 |
| 夜診 | 葉國偉(北) | | 葉育欣 | 歐良修(北) | 林思偕 | |

   ✔ Fellow 總醫師：曾吉騰(53650)、黃柏翰(35793)
2. **查房：晨會前看過全數病人**，建議早上 6:30～7:00 到病房。若病情有變化，要優先處理。
   下班前再看病人，有特殊狀況時，請主動告知 Fellow 或主治醫師，並主動交班給值班醫師。
3. **開 Order 提醒**：緊急重要的 order 務必先開立，「病歷紀錄」絕對不能凌駕 order 之前！
   ✔ **接新病人**：請先 history taking 和 PE 後，再開立 admission order。門診或預住院新病人請務必注意住院通知單上交代事項。
   ✔ **自費檢驗項目**（包含自費過敏原）：可從本科範本點選，務必印出檢查單及蓋章。
   ✔ **兒科常用檢查**：可參見兒童內科部工作手冊內容開立，一律要在**檢查單上註明 Indication，**並印出來蓋章、註明檢查地點、時間，夾入病歷夾，放入護理站盒子。
   提醒：心臟超音波 for Kawasaki Disease 一定要註明身高、體重。Joint echo 和甲摺鏡：開單完不會跳排程，需要跟 fellow 約檢查時間。
   ✔ Order renew: 如有複雜的 case 每一段時間，請 order renew。ICU 轉出者，也需 order renew。
   ✔ **出院開立**：請備妥出院三寶：出院藥單、出院照護計畫書以及診斷書（PRN）。
   白班有預計明天要出院的，可先開立**「今辦明結」或「今辦明出」**
      ✧ **Discharge Today:** 配合醫院規定，務必白天十點前開立。
      ✧ **今辦明出**：所有帳都結清並鎖檔。出院前不會開到任何 order，適合較單純的 case；
      ✧ **今辦明結**：明天才結帳，晚上可能會調整 order，比較適合是發燒剛退、氣喘等。
      ✧ **假日提醒**：尤其禮拜五，接連六日假日，若預計出院，請務必開好「今辦明結」或「今辦明出」，並可先暫存好 discharge note。備妥出院三寶。
      ✧ **特殊案例**：如有個案下次住院必須安排檢查、檢驗項目（包含 study 血）或是特殊用藥，請務必在下次住院通知單上，詳細註明檢查檢驗項目以及藥物劑型、劑量。舉例：請抽 IgG/A/M/E, 並給予 IVIG(3g/vial)共五瓶。
4. **病歷撰寫**：
   ✔ **Admission Note**：年紀身高體重不要計算錯。生長發育、疫苗史等，範本不要帶錯。
   ✔ **Progress Note**：以重點為主，請記錄 VS comment，至少一週要完成兩次 VS teaching。病情改變時要記錄及修改 Problem Oriented Sheet。

林口長庚 兒童過敏氣喘風濕科

- ✧ 病情複雜病人（如 SLE）請詳細整理 Lab sheet 及檢查結果，有照 X 光片一定要在 progress note 中寫上判讀
- ✧ SLE 病患：SLEDAI 評分在 progress note 範本，選 SLE endoxan 檢驗單分散於 S 與 O。

✔ **Off Service Note**：最後一天或交接月份，務必完成。

✔ **Discharge Note**：記得 multiple diagnosis，尤其是 SLE fresh case 要把所有的 complications 確實記錄。如需執行 renal biopsy 的 case，請與 Fellow 討論診斷內容。

✔ **每日的病歷：**請及時完成，發揮互助，遇上個月份/半月出院病歷未完成，請協助完成。

5. **交接班**：pm off/day off、上下半月交替月份等狀況，請主動確實與代理人/交接人進行交接班。
6. **自主學習**：
   - ✔ 本科門診區位於兒童大樓 L 棟地下一樓，且設有「兒童過敏氣喘中心」，可至兒童過敏氣喘中心觀摩肺功能檢查以及氣喘衛教。
   - ✔ 本科病人以 asthma、呼吸道感染症（pneumonia, bronchiolitis, croup…）、urticaria、SLE、JIA 居多，亦可看到其他兒科常見疾病，有空時請多念 UpToDate, Nelson 等相關主題。
7. **其他提醒**：上班期間公務機維持暢通。不遲到不早退。病人變化新病人多時，請互相幫忙。

**##科內 meeting##**

1. **科內晨會：每週四上午 7:30~8:30，在 10 樓討論室**。務必準時出席！
   以本科臨床 case 討論為主；提醒大家務必熟悉自己 team 上的病人，晨會中會隨機抽點。*晨會前約七點二十分時，請協助搬椅子進討論室*，Clerk 醫師或住院醫師請協調一人負責撰寫晨會紀錄。被抽點評比病歷，住院醫師或 Clerk 醫師會後務必刷 QR code 進行回覆。晨會結束請各位醫師協助將椅子歸回原位。
2. **Combined Meeting：**每雙週四 11:00~12:00，在 12L 會議室。和成人風濕科合開，請準時出席。
3. **Seminar**：單數週不定時會舉辦，會提前於週四次專科 meeting 時公布。
4. **##學習重點##**

| | |
|---|---|
| ● Dehydration Sign：區分 mild, moderate, severe<br>● Fluid supplement 原則<br>● Vaccination 現行預防接種時程及自費疫苗<br>● Development milestones<br>● CXR description & interpretation<br>● Wheezing 的 differential diagnosis（至少 10 個）<br>● Diagnostic criteria of SLE 及如何判斷 SLE flare-up<br>● Side effects of systemic corticosteroid<br>● Kawasaki disease<br>● 如何診斷、治療、控制氣喘<br>● Pneumonia 在兒科病人不同年 pathogen<br>● Physical examination 基本評估的 3A | ● 氣喘嚴重度評估表（Asthma severity score 評分在 progress note 病歷範本中，有 Asthma severity GINA-2009 及 Pulmonary Index Score 兩種可供選擇，請選擇一種每日評估並記錄於病歷中）<br>● 鑑別 Asthma/bronchiolitis/pneumonia/atypical pneumonia<br>● Nephrotic syndrome & Nephritis<br>● 兒童不同年紀 CBC 的變化<br>● Anemia 的鑑別診斷、RBC morphology、Mentzer index<br>● Arthritis 與 Arthralgia 有何不同<br>● Diagnostic criteria of JIA<br>● 何時需要懷疑 Primary immunodeficiency？ |

林口長庚 兒童過敏氣喘風濕科

**##特殊 Order##**

1. **Rheumatology**:常用於 **SLE 或 JIA** 病患

   Endoxan/Methylprednisolone pulse therapy 範本於本科醫囑範本。開立時請告知總醫師。
   (要記得要開抽血單、病人平時用藥的自備藥囑(請查看門診紀錄)，及**完成 SLEDAI** 喔！)

   ✔ **Methylprednisolone Pulse Therapy**:（醫囑請選本科範本Methylprednisolone Admission order）

   Dosage (3-18 歲)：**10~30 mg/kg**，一天一劑，通常三劑打三天。

   Maximum dose：usually **1 g** (exceptionally up to 2 g)

   ✧ **治療時注意事項：**

   1. Hypertension/Hypotension－significant changes in systolic and/or diastolic pressures.
   2. Tachycardia or any pu1se changes in rate or regularity.
   3. Blurring of vision, flushing, sweating.
   4. Any exacerbation of previous symptoms.
   5. “Bad taste” in mouth.

   ✧ **如果有上述的情況發生，可以遵循下列的處理原則：**

   If significant BP changes from baseline readings：

   1. **Decrease rate of infusion by approximately half**, **or discontinue** if BP does not return to baseline within 15 minutes.
   2. Recheck BP every15 minutes until stable.
   3. Record any unusual side effect that may occur.(寫一份 duty note 紀錄病人狀況與處理過程)
   4. 電話通知 fellow

   ✧ **SPECIAL CONSIDERATIONS:**

1. There have been a few reports of cardiovascular collapse associated with a rapid intravenous administration of large doses of methylprednisolone (greater than 500 mg). The cause and relation to other medications (ex. diuretics) is unknown.
2. Some children experience a “tired feeling” after the infusion and may appear temporarily lethargic.
3. **Hypertensive crisis** 時要 hold methylprednisolone (repeat later when BP stable), 可 Adalat 舌下 stat.

林口長庚 兒童過敏氣喘風濕科

✔ **Cyclophosphamide(Endoxan) Pulse Therapy Order**:

（開立簡易 **Admission order、Endoxan 抽血檢驗單、門診用藥**即可，其餘請 **call fellow** 開立）

（抽血檢驗單，請選本科範本 **- SLE Endoxan 檢驗單 - Admission order**）

✧ **Endoxan pulse therapy 注意事項**:請安排白天執行，小夜或假日入之新病人請先開醫囑領藥

★ Endoxan 第一次打 0.5gm/$m^2$，第二次打 0.75gm/$m^2$，之後打 1 gm/$m^2$。但如果病人的 lab 發現 ANC ＜1500、Granulocyte＜1000 或 WBC＜2000 不增加劑量

★ 在 JIA 的病人是以 Endoxan(0.5 g/$m^2$ 固定)，再加上 Methylprednisolone(30mg/kg 一劑即可)

★ 在 IVF hydration 完後要記得把 IVF 改回 maintenance dose，不要因為 over-hydration 造成 iatrogenic side effect (ex. brain edema, pulmonary edema….)

★ Endoxan side effect：nausea, vomiting, hemorrhagic cystitis, BM suppression(nadir 10-14days), alopecia and infertility

**★ 出院 10 至 14 天後安排回診**

**★ 出院醫囑請開急單 W.B.C、U/A 於回診時檢查**

★ 治療期間注意 SIADH 的症狀，如 oligouria、Urine Na or osmo 上升、dizziness 甚至 conscious disturbance。如果發生，可以先使用利尿劑(furosemide)治療，並要電話通知 fellow！

✔ **MMF order** : 若為 Mycophenolate mofetil 250mg(MMF)或 Mycophenolate sodium 180mg(Myfortic)而住院，請記得務必開立"**自費**"使用。請特別留意 MMF 與 Myfortic 不要開錯!

✔ **Renal biopsy** : 若有要作 renal biopsy，請視情況會診腎臟科曾敏華醫師，相關醫囑請依兒童腎臟科範本開立（請特別留意需抽 platelet function closure time，PT，aPTT）。

林口長庚 兒童過敏氣喘風濕科

2. **Immunology**:

✔ **Primary immunodeficiency**:

✧ 病人需常規注射 IVIG，如有住院病人請留意過去注射的劑型(分為 3g/pc or 5g/pc)：
因為他們是長期使用血液製品的族群，錯誤的劑型可能會有 anaphylaxis 的風險；儘管這些病人規則住院的 order 通常不會更動，但每次開立這些病人的入院醫囑前，仍請留意住院單上是否有交代新增的抽血項目或 IVIG 劑量調整。

✧ 這類病人出院，請記得在「住院通知單」上，註明下次的治療計劃：
舉例：IVIG(3g/vial) 打 5 瓶，抽：CBC/DC, IgG, 順抽 study 血品（綠頭管一管,滿管）。

| 檢查代號 | 項目 | 檢查代號 | 項目 |
|---|---|---|---|
| **Lung Function Test ( L棟B1氣喘中心，分機8770)** | | **免疫功能檢查** | |
| M32-053 | Vitalography(肺功能) | L72-266 | T cell & B cell |
| M32-317 | Simple bronchodilator test(停一次吸藥) | L72-267 | T cell subset analysis |
| M32-315 | Methacholine challenge test | L72-272 | T cell subset 2 |
| M32-321 | Exhaled NO test | 基本免疫篩檢L72-266, 267, 272 + IgG/IgA/IgM/IgE | |
| **甲摺鏡/ Joint echo,聯絡檢查fellow,帶病人至B1衛教室** | | 基本免疫篩檢：266, 267, 272選T+B+NK<br>T cell subset：266, 267, 272選T cell subsets<br>B cell subset：266, 267, 272選B cell<br>T helper cell：266, 267, 272 選 T helper<br>T cell receptor(TCR)：266, 267, 272 選 TCR<br>T reg cell：267, 272 選 Treg | |
| M25-219-Z | Nailfold capillaroscopy 甲摺鏡 | | |
| S46-201-Z | Joint echo 關節超音波 | | |
| S46-200-Z | Joint echo 關節腔抽吸 or 注射 | | |
| M25-012-Z | Saliva production 唾液檢查 | | |
| **健保過敏原測試：A+C (+-Phadiatop infant allergen test)<br>自費過敏原測試：D (自費)** | | **Rheumatology 檢驗** | |
| (A)M32-327 | Total IgE | L72-217/219 | C3/C4 |
| (B1)M25-130-Z | MAST allergen system | L72-245 | Antinuclear Ab (ANA) |
| (B2)M25-131-Z | CAP allergen system | L72-247 | Anti-dsDNA Ab |
| (C)M25-133-Z | E.C.P (Eosinophil Cationic Protein) | M25-212-Z | Anti-RNP/Anti-Sm |
| (D)M32-332 | Food(I) 25項(4000元) | M25-213-Z | Anti-SSA/Anti-SSB |
| (D)M32-333 | Food(II) 25項(4000元) | M25-216-Z | Anti-cardiolipin-IgG |
| (D)M32-334 | Food(III) 25項(4000元) | M25-216A-Z | Anti-cardiolipin-IgM |
| (D)M32-339 | Pet and Mold Allergy(4000元) | M26-094 | Lupus Anticoagulant test |
| (D)M32-338 | Insect and Drug Allergy(4000元) | M25-137-Z | Anti-B2-glycoprotein-1 Ab |
| L72-062 | Absolute eosinophil count | M25-139-Z | Anti-citrullinate filaggrin Ab |
| M25-134-Z | Phadiatop infant allergen test | M25-218-Z | Anti-ENA(RNP/Sm/SSA/SSB) |
| **藥物過敏檢測** | | M25-223-Z | Anti-neutrophil cytoplasmic Ab (含c-ANCA, p-ANCA) |
| L72-D33/34/35/39 | Lymphocyte transformation test (一項/五項/十項/一項)/（$4000/4800/6500/健保） | M25-156 | Myositis panel |
| L72-D36/37/38 | Histamine& leukotriene release test (一項/五項/十項)/（$4500/6000/7500） | M25-158 | Autoimmune hepatitis panel (SLA/LP,SLC,LKM-1,AMA-M2) |
| L72-D32A | Tryptase test | M72-665 | Disease associated HLA antigen (HLA-B27) |
| L72-D30/31 | CAP drug specific IgE test (五項/九項)/（健保/$3200） | L72-241 | Cryofibrinogen identification |
| **PAOD/DVT (CV1分機2366, CV2分機2443)** | | L72-239 | Cryoglobulin identification |
| M22-073 | Dupplex Color Scan arterial | L72-291 | IL-6 (自費600元) |
| M22-074 | Dupplex Color Scan vein | M25-146 | Tumor necrosis factor-α |

林口長庚 兒童過敏氣喘風濕科

**關節腔抽吸**

Echo-guided needle aspiration S46-200-Z
Synovial fluid aspiration M25-063-Z (小兒科), Synovial fluid analysis L72-759, sugar A.C.
Gram' stain, Acid fast stain, mycobacterial smear and culture, total protein, common aerobic culture
Heparin lock flush 100 u/mL, 10mL/pc
Lidocaine HCL 1%, 5mL/amp
Triamcinolone acetonide (IM) 40mg/1mL/amp (有需打藥時再開即可)

**過敏原檢測**

健保：開單 A+C。請在病歷上記載相關過敏性疾病 (包含氣喘/過敏性鼻炎/異位性皮膚炎)
若合併 Total IgE、eosinophil count 或 ECP 升高，才可繼續開立健保檢驗項目 B1 or B2
自費：開單健保 A+C，加上 D (自費) 和 B2( 自費/ 存檔後點選 1)。請務必印出檢驗單
補充：B1 MAST allergen test（可驗 35 種），B2 CAP（有七種，可選一細項）

| CAP allergen system細項： |
|---|
| 套組一：< Inhalant 1 > 塵蟎、五爪蟎、蟑螂、鴿糞、家塵 |
| 套組二：< Inhalant 2 > 貓毛、狗毛、鼠類上皮、黴菌綜合、花粉綜合 |
| 套組三：< Food 1 > 蛋白、牛奶、小麥、花生、大豆、麩質 |
| 套組四：< Food 2 > 鱈魚、螃蟹、蝦、龍蝦、蚵仔、扇貝 |
| 套組五：< Fruit 1> 柳橙、奇異果、香瓜、芒果、鳳梨 |
| 套組六：< Fruit 2> 木瓜、酪梨、香蕉、西瓜、草莓 |
| 套組七：< Fruit 3> 櫻桃、蘋果、檸檬、梨、桃子 |

**自費項目**

開立：醫囑 + 材料醫囑 + 印出批價單(批價單需備註)。開單記得確認料號，家屬需簽自費同意書
醫囑範本：Avene cream,自費,料號:68-007-005059, 庫台 4A010,書記批價後請病人至 B1 氣喘中心領取

| 項目 | 料號 | 價錢 | 項目 | 料號 | 價錢 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aerochamber<br>吸藥輔助器 | 84-935-060081 | $1270 | Neo VIDERM<br>加納軟膏 (100ml) | 68-007-100000 | $2100 |
| Peak flow meter<br>峰速計 | 84-935-040300 | $580 | Atopiclair cream<br>愛妥麗保濕敷料(乳霜) | 68-007-009101 | $1200 |
| Pocket air<br>帕基艾兒攜帶式噴霧器 | 84-998-700000 | $3900 | Atopiclair lotion<br>愛妥麗保濕敷料(乳液) | 68-007-009102 | $1250 |
| **舒喜滿**Baby Spray (115ml)<br>洗鼻液 溫和型(young child) | 68-045-000115 | $500 | Sinomarin/Gerolymatos<br>**希諾寧**高張洗鼻器 | 84-985-100125 | $540 |
| **舒喜滿**Gentle Jet (135ml)<br>洗鼻液 一般型 (>6 yr) | 68-045-000135 | $500 | Sea water solution<br>**舒鼻淨** | 68—045-100100 | $500 |
| **舒喜滿**Strong Jet (210ml)<br>洗鼻液 醫用型(>10 yr) | 68-045-000210 | $500 | | | |

料號補充(濕敷使用)：
4 吋燙傷紗布 84-131-203521 35 元；4 吋彈性繃帶 84-072-100040 30 元
6 吋彈性繃帶 84-072-150040 25 元；網狀彈性繃帶(股) 84-086-220600 60 元

林口長庚 兒童過敏氣喘風濕科

【常見藥物】

**Atopic Dermatitis:**

✔ (類固醇藥膏 potency 由輕至重)

Hydrocortisone/Fluticasone cream (可用於臉部) -> **Mometasone** cream -> Betamethasone ointment (身體); 頭皮的部分可以搭配 clobetasol shampoo

B-N (Betamethasone + Neomycin) ointment/ Flucort-F (膚潤康) Fluocinolone 0.25mg + Fradiomycin (用於合併傷口的濕疹部位)

✔ 衛教：保濕乳液，避免刺激物和過敏原。可選異位性皮膚炎適用乳液（可至 B1 試擦再選擇）

✔ 濕敷：入院濕敷患者，請務必住院時，立即開立用藥，和病患約下班前的濕敷時間。

(濕敷醫囑：請參見本科範本 - Atopic dermatitis score - Daily order)

✔ 如果是大小孩會使用到 6 吋的彈性繃帶，請把組套預設彈繃料號請改成 84-072-150040。

✔ 欲使用醫藥級乳液，有兩款：愛妥麗(Atopiclair)跟加納軟膏(Neo Viderm)，記得點選本科範本-自費耗材範本，要有文字 order 跟計價單。

✔ 可以的話請幫忙病人評 EASI and SCORAD score。(有結構化病例範本)

✔ 杜避炎(Dupilumab：Anti-IL-4R)：生物製劑，適用於重度、難治的異位性皮膚炎患者，劑量和施打頻率依據病人的體重計算(請參考下圖)：




台灣兒童異位性皮膚炎
臨床診療指引 2021 版

林口長庚 兒童過敏氣喘風濕科

✔ 銳虎(Upadacitinib: JAK inhibitor)：口服小分子藥物，適用於 12 歲以上重度、難治的異位性皮膚炎患者，但使用前需抽血驗 CBC/DC, AST/ALT, viral hepatitis panel and Quantiferon test (check if had TB)，服藥中也需監測是否發生 anemia, neutropenia, lymphopenia or hepatitis, dyslipidemia. 如下圖：

**Monitoring: 在開始用藥前和用藥中須注意紅血球、白血球(淋巴、嗜中性)、血脂和肝指數並且留意病人是否有結核、病毒性肝炎或嚴重感染的情形。**

| | | Laboratory parameters | | | | | Screening tests/evaluations | | | | Serious infections |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ALC | ANC | Hb | Lipids | AST/ALT | TB[h] | Viral hepatitis | Skin[i] | Vaccines | |
| Evaluate | At baseline | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ |
| | ≤12 weeks after initiation | | | | ✓ | | | | | | |
| | According to guidelines or routine management | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Treatment should not be initiated, and/or should be interrupted, in patients with: | | <0.5 × $10^9$ cells/L[j] | <1 × $10^9$ cells/L[j] | <8 g/dL[j] | | Increased AST/ALT and suspected drug-induced liver injury | Active TB | | | | Active, serious, or opportunistic infection[k] |

[h]Anti-TB therapy should be considered prior to initiation of upadacitinib in patients with previously untreated latent TB or in patients with risk factors for TB infection. [i]NMSCs have been reported in patients treated with upadacitinib. Periodic skin examination is recommended for patients who are at increased risk for skin cancer. And may be restarted once ALC/ANC/Hb returns above this value. [k]Including localised infections. Patients should be closely monitored for the development of signs and symptoms of infection during and after treatment with upadacitinib. A patient who develops a new infection during treatment with upadacitinib should undergo prompt and complete diagnostic testing appropriate for an immunocompromised patient; appropriate antimicrobial therapy should be initiated, the patient should be closely monitored, and upadacitinib therapy should be interrupted if the patient is not responding to antimicrobial therapy. Upadacitinib therapy may be resumed once the infection is controlled.

ALC, absolute lymphocyte count; ALT, alanine transaminase; ANC, absolute neutrophil count; AST, aspartate transaminase; Hb, hemoglobin; TB, tuberculosis

abbvie JAKa-TW-00083-FM (Approved date: 2022/04/07)

林口長庚 兒

## Allergic Rhinitis:

✔ 衛教：洗鼻液，避免刺激物和過敏原，藥物治療

✔ 藥物治療主要依據病人過敏性鼻炎的嚴重度以及對生活的影響作決定：可參考下列台灣過敏學會針對過敏性鼻炎治療的 flowchart。

✔ 鼻噴劑 (in each nostril)：

| | | |
|---|---|---|
| Cromolyn nasal solution：肥大細胞穩定劑<br>(Allergocrom, 艾麗) 非類固醇 | 1puff TID-QID | 適用兩歲以上 |
| Azelastine HCL nasal spray (anti-histamine)<br>(Azetin, 噴立停) H1 blocker | 5-11y/o-1puff BID,<br>>11y/o-1~2puff BID | 適用五歲以上 |
| Fluticasone furoate nasal spray<br>(Avamys, 艾敏釋) | 2-11 y/o-1puff QD,<br>>11y/o-1~2puff QD | 適用兩歲以上 |
| Mometasone furoate nasal spray<br>(Nasonex, 內舒拿) | 2-11y/o-1puff QD<br>>11y/o-1~2puff QD (max: 4puff/dose) | 適用兩歲以上 |
| Triamcinolone acetonide nasal spray<br>(Nasacort, 拿塞可得) | 6-11y/o-1puff QD,<br>>11y/o-1~2puff QD | 適用六歲以上 |

✔ 常見口服抗組織胺藥物：

| | | |
|---|---|---|
| Cetirizine oral soln 1mg/ml<br>(Zytec, 勝克敏液) | 2-6y/o – 2.5ml<br>>6y/o – 5ml | HS-Q12H |
| Levocetirizine 5mg/tab<br>(Xyzal, 趨異樂) | 6mo~5yo: 1.25mg<br>6~11yo: 2.5mg<br>>12yo: 5mg | HS |
| Cyproheptadine: < 1 ml/kg/day<br>(Periactin, 希普利敏) | BW/4 ml | TID-QID |

林口長庚 兒童過敏氣喘風濕科

✔ 洗鼻液：

| 名稱 | 料號 | 自費價格 |
|---|---|---|
| Baby spray 洗鼻液 (young kid) | 68-045-000115 | $500 |
| Gentle jet 洗鼻液 (>6 yr) | 68-045-000135 | $500 |
| Strong jet 洗鼻液 (>10 yr) | 68-045-000210 | $500 |
| Sinomarin 希諾寧高張洗鼻器 | 84-985-100125 | $540 |

台灣過敏性鼻炎診斷及
免疫療法之建議流程

## Asthma：

| | | |
|---|---|---|
| Montelukast 欣流：健保給付不包括六個月以下嬰幼兒 | | |
| 6m/o-2y/o | Montelukast sod. Oral Granules 4mg/pack | 1pc HS |
| 2y/o-6y/o | Montelukast sod. (六歲以下) 4mg/chewable tab | 1pc HS |
| >6y/o | Montelukast sod.(小兒用) 5mg/chewable tab | 1pc HS |
| Fenoterol | [Berotec,適喘寧,水蜜桃味]：0.5mg/ml, 60ml/bot, < 1ml/kg/day, QID (=BW/5ml, QID) | |
| Procaterol | [Meptin,喘解液,葡萄柚味]：5ug/ml, 60ml/bot, <0.5ml/kg/day BID | |
| Salbutamol 2mg/tab | 2~6 yr | 0.1~0.2mg/kg/dose TID |
| | 6~12 yr | 2mg/dose TID |
| | >12yr | 2~4mg/dose TID |

*氣喘急性發作期使用 IV methylprednisolone 換成口服 prednisolone 通常給 1mg/kg/day，請大家注意出院帶藥類固醇天數 **(IV+PO 時間不超過 7 天)**。

| | | |
|---|---|---|
| **吸入型藥物：**(小於六歲一律加開自費吸藥輔助器 aerochamber) | | |
| **急救用藥(SABA)** | | |
| Ventolin inhaler<br>(Salbutamol,泛得林) 100mcg/ds | | 1-2puff st, and q20min |
| Fenoterol metered aerosol<br>(Berotec,備勞喘)100mcg/puff | | 1-2puff, 若吸入 5 分鐘後呼吸沒改善，可投第二個劑量 |
| 以上急救用藥，若投予數個劑量治療仍未改善，此時應立即就近送醫 | | |
| **保養用藥(Controller)** | | |
| 1- 4y/o | Fluticasone evohaler MDI(輔舒酮 定量吸入器) 50mcg/ds | 50-100mcg BID |
| >4y/o | Fluticasone evohaler MDI(輔舒酮 定量吸入器) 50mcg/ds | 50-200mcg BID |
| | Seretide 50 evohaler MDI (使肺泰 定量吸入器)<br>(Salmeterol 25mcg+Fluticasone 50mcg) | 1-2 puff BID |
| | Seretide 100 accuhaler (Salmeterol 50mcg+Fluticasone 100mcg) | 1puff BID |
| 12 y/o | Seretide 250 accuhaler (Salmeterol 50mcg+Fluticasone 250mcg) | 1puff BID |
| | Symbicort **Turbuhaler** (吸必擴 乾粉吸入器)<br>( Budesonide 160mcg+ Formoterol 4.5mcg) | 1~2 puff BID |
| | Symbicort Rapihaler MDI (吸必擴 定量吸入器)<br>( Budesonide 160mcg+ Formoterol 4.5mcg) | 1~2 puff BID |
| | Fluticasone accuhaler 250mcg/ds (少用於小孩) | |

林口長庚兒童過敏氣喘風濕科

2023 GINA Guideline for Asthma

*MDI 是定量吸入器，而 DPI 是乾粉吸入器，通常是用於手腳協調以及肺功能好的病人，如 adolescent 或是 school-aged children。

*如果是第一次使用吸入型藥物，記得請病人下去 B1 衛教室學習正確吸藥技巧。

## Urticaria：

Severe—Methylprednisolone 0.5-1mg/kg/day q6h IV + Diphenhydramine(Vena)1mg/kg/dose q6h IV or Periactin PO 可加用 Ketotifen 1mg/cap, 6mo-3y/o: 0.05mg/kg BID, adult: 1mg BID

## Kawasaki disease：

IVIG：3gm/vial, **2g/kg/day** 取整數給予[請點選範本，前 30 分鐘測試 5cc，剩下的後面 11.5 小時給完]

Aspirin：

Moderate dose: 40-50mg/kg/day QID (for anti-inflammatory effect)

燒退兩天之後改為 3-5mg/kg/day QD, 持續兩個月 (for anti-thrombotic effect)

**Kawasaki disease 是否要用 moderate dose(for anti-inflammatory effect)或是用 low dose(for anti-thrombotic effect)可以做 SDM(shared decision making)，請開 order-SDM。點選 Kawasaki disease 那一項。

## Anaphylaxis：

第一線藥物

Epinephrine：

IM 1:1000, 0.01 ml/kg (0.01 mg/kg); max 0.5 ml, interval 5~15 min, Repeat 2~3 times 施打於大腿外側。

- ✔ 若是針對 recurrent anaphylaxis 或 high risk of anaphylaxis 病人會考慮開 EpiPen(是 Epinephrin autoinjector)，有兩個劑型，一個是 0.15mg(綠色)，適用於 15-30 公斤的小朋友，一個則是 0.3mg(橘色)，針對 30 公斤以上的病人。
- ✔ 此外一些 adjuvant therapy 如 anti-histamine (ex: Cetirizine; Hydroxyzine; Loratadine; Fexofenadine; Diphenhydramine; Famotidine)，bronchodilator and steroid。但就最近的 Guideline 和 Systematic Review 顯示 steroid 沒有很強實證有效。

林口長庚 兒童過敏氣喘風濕科

其他 Naproxen：止痛效果－10 mg/kg/day BID ; Anti-inflammatory effect－20-30mg/kg/day BID